

Разговор про гормональную терапию

Лист к выпуску «Перименопауза, день 7». Это не назначение и не инструкция: это то, с чем идут к врачу и к чему возвращаются потом сами. Ответы записывайте прямо здесь, пока помните.

Дата _____ Врач _____

1. Подхожу ли я по срокам?

Сколько лет прошло от последних месячных и в каком я месте по времени.
Окно: примерно 10 лет от последних месячных или до 60 лет.

2. Какая форма предлагается и почему именно она?

Через рот и через кожу это разные истории. Таблетка проходит через печень, пластырь и гель идут мимо неё, поэтому по тромбам через кожу спокойнее. Но у кожи свои минусы: отклеивается, дороже, доза подбирается дольше.

3. Какой второй гормон и почему именно он?

Если матка есть, к эстрогену обязательно добавляют второй гормон. Их несколько: микронизированный прогестерон, дидрогестерон, синтетические. По груди они выглядят по-разному. Это вопрос, а не требование.

И ЕЩЁ ДВА, ЕСЛИ ОНИ ПРО ВАС

4. Мне нельзя системную. А местную можно?

Это разные разговоры. Отказ от одной не означает отказа от другой. Если был рак груди, решает онколог.

5. Когда мне делать маммографию и что учесть?

У части женщин на терапии ткань груди становится плотнее, а на плотном фоне снимок читать труднее.

И не забудьте пять общих вопросов, они работают на любом приёме

На основании чего поставлен диагноз · Что будет, если не лечить
Как и когда мы поймём, что терапия подействовала · Какие обследования проходить
Когда мы вернёмся к этому решению и пересмотрим его
Они на листе «5 вопросов врачу». Если его нет под рукой, перепишите отсюда.

Что важно понимать про терапию

Это не назначение и не инструкция. Это то, к чему стоит возвращаться самой, когда придёт время решать.

ОКНО

Начинать имеет смысл в течение 10 лет от последних месячных или до 60 лет. В этом коридоре соотношение пользы и риска самое благоприятное. Позже терапию тоже назначают, просто разговор идёт другой. И помните: дату последних месячных подтверждают только через год после них.

ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ И ЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ

Делает, и это доказано

Снимает приливы и ночную потливость
Помогает со сном, когда он ломается из-за этого
Работает с сухостью и дискомфортом
Защищает кость, уменьшает переломы
Помогает с подавленностью, начавшейся вместе с остальными симптомами

Не делает

Её не назначают ради профилактики болезней: инфаркта, инсульта, деменции
Не сохраняет мышцы и не замедляет их потерю. Мышцы держат силовые, белок и витамин D
Не защищает от беременности

СИСТЕМНАЯ И МЕСТНАЯ ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ

Системная: таблетка, пластырь, гель, спрей. Гормон идёт в кровь и работает на всё тело.
Местная: крем, свечи, кольцо. Работает там, куда приложили, в кровь попадает совсем мало.
Многим женщинам, которым нельзя системную, местную можно.
И по одной вещи они работают в разные стороны: системная через рот может ухудшить подтекание мочи, а местная мочевые симптомы наоборот уменьшает.
Если вам выписали крем, а вы прочли вкладыш, испугались и убрали его в ящик, вернитесь к этому разговору с врачом. Сухость и жжение лечатся, и лечатся хорошо.

Если вам нет 40, правила переворачиваются

Когда яичники выключаются до 40 лет, это отдельный диагноз. Терапию там назначают примерно до 51 года, то есть до возраста, в котором менопауза наступила бы сама. И назначают даже тем, у кого симптомов почти нет: ради защиты кости и сосудов. Именно этим женщинам терапию недоназначают чаще всего, перенося на них риски, изученные у женщин намного старше.

Что обычно спрашивают

Короткие ответы на то, что возникает уже после приёма.
Всё это можно и нужно уточнять у своего врача.

А в перименопаузе не рано?

Нет. Терапию назначают и когда цикл ещё идёт, для этого есть отдельные схемы. Разница в том, что своих гормонов тут не мало, они скачут, поэтому подбор тоньше и врач нужен внимательнее. Сложнее, но это не повод ждать десять лет.

Сколько лет это можно пить?

Правила «максимум пять лет» больше нет. Нет цифры, после которой положено бросать. Есть другое: примерно раз в год вы с врачом возвращаетесь к этому решению и смотрите, нужно ли продолжать и в той же ли форме.

Когда я пойму, что работает?

Приливы обычно отступают в первые недели. Но оценивать по-настоящему стоит через два-три месяца: тело привыкает, и начало может быть неровным. Не бросайте на десятый день, решив, что не помогает.

Появились мажущие выделения, это нормально?

В первые месяцы на схемах, где цикл ещё идёт, бывает часто. Правило простое: любое кровотечение, которое вас удивило, показываем врачу.

Раз я на терапии, предохраняться не надо?

Надо. Доз там в разы меньше, чем в противозачаточных, овуляцию они не останавливают. Ориентир: последние месячные после 50, предохраняться ещё год. До 50, два года. Считается от своих месячных, а не от кровотечений на фоне терапии. Уточните это у врача, многое зависит от того, чем вы предохраняетесь сейчас.

А почему терапию могут не назначить?

Причина обычно одна из двух. Либо есть что-то, что эстроген может подстегнуть: рак груди сейчас или в прошлом, другие гормонозависимые опухоли. Либо высокий риск тромба: тромбы в прошлом, наследственная склонность, инфаркт или инсульт. Сюда же тяжёлые болезни печени. Отдельно стоит невыявленное кровотечение из матки: тут запрет временный. И почти всё это про системную терапию, местная разрешена шире.

КАК НАЙТИ СВОЕГО ВРАЧА

Менопаузы почти нет в обязательной подготовке врачей. Тот, кто в ней разбирается, выучил всё сам. Поэтому ищите не страну и не клинику, а конкретного человека.

- Профильное врачебное общество вашей страны. В Польше это Польское общество менопаузы и андропаузы. Где-то там есть список врачей, где-то хотя бы фамилии тех, кто по теме выступает и пишет
- Женские чаты вашего города: такие фамилии там передают из рук в руки
- Ищите слово «менопауза» прямо в описании специализации, а не просто «гинеколог»

Мой врач: _____

Кто посоветовал: _____